Organiser la réponse intersectorielle aux besoins sociaux complexes et co-occurrents en soins primaires

Configuration des réseaux adaptés aux différents profils de patients pris en charge



Eric Bernier, LL.M. et M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
Doctorat en santé publique · Systèmes, organisations et politiques de santé · ESPUM, Université de Montréal

SOUS LA CO-DIRECTION DES
Dres Nadia Sourial et Géraldine Layani

01 Contexte

En soins primaires au Canada, 1 patient sur 2 déclare un besoin social · *Kosowan et al., 2025*

19 %
des ménages québécois en insécurité alimentaire en 2023 (14 % en 2018)
ISQ, 2026

40 %
des ménages qui paient la moitié de leur revenu en logement : se loger ou se nourrir
ISQ, 2026

TROIS NOTIONS À DISTINGUER

La co-occurrence se compte ; la complexité se décrit ; la réponse intersectorielle s'organise sur un territoire.

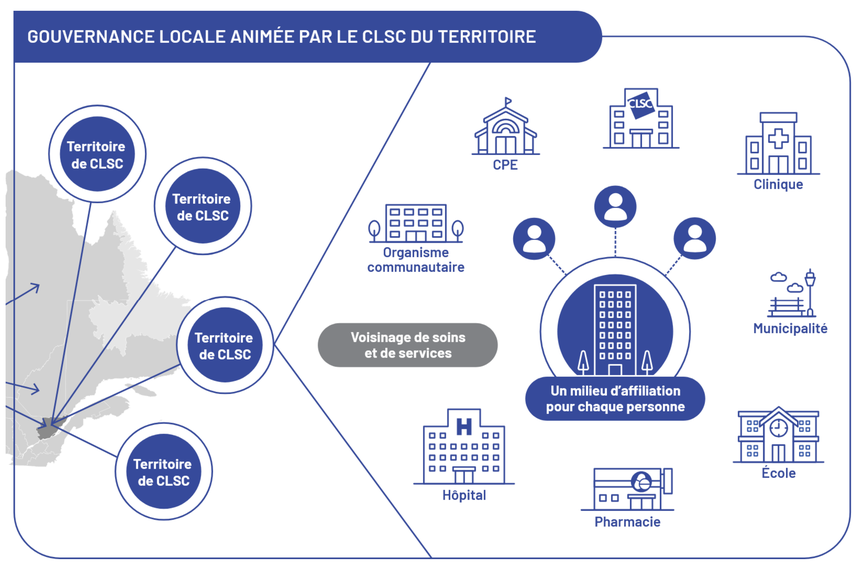
CRITÈRE D'INCLUSION
Co-occurrence
Au moins deux besoins sociaux présents en même temps.
Kreuter et al., 2021

DÉCRITE, PAS EXIGÉE
Complexité
Cumul de maladies chroniques, d'incapacités, de problèmes de santé mentale et de vulnérabilité sociale.
Kuluski et al., 2017

S'ORGANISE SUR UN TERRITOIRE
Réponse intersectorielle
Actions d'autres secteurs que la santé, menées avec elle, sur la santé ou ses déterminants : CLSC, hôpital, GMF, pharmacies, organismes communautaires, municipalité, écoles, CPE, privé.
MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013

POLITIQUE DE PREMIÈRE LIGNE · MSSS, 2026

Le territoire de CLSC devient l'unité de référence



QUATRE RÔLES DU CLSC
Navigateur · Coordonnateur · Leader intersectoriel · Coanimateur

« dans un esprit de gouvernance partagée » · MSSS, 2026, p. 42 · schéma : MSSS, 2026

EXEMPLE FICTIF · FIL ROUGE
Mme Protocole · 58 ans
Qui répond ? Avec qui ? Qui coordonne ?

Avis d'expulsion → Insécurité alimentaire → Dettes → Dépression (contexte clinique)

LA LACUNE

Le CLSC doit coordonner. Mais pour une combinaison de besoins, rien ne dit quels partenaires mobiliser, comment les relier ni qui coordonne. **On connaît la programmation, pas les réseaux réellement constitués autour des parcours.**

QUESTION DE RECHERCHE

Comment s'organise la réponse intersectorielle aux différents profils de patients ayant des besoins sociaux complexes et co-occurrents pris en charge en soins primaires ?

But : relier chaque profil à… un profil de besoins → une configuration de partenaires → et son coordonnateur

02 Méthodes

Terrain : 3 territoires de CLSC contrastés en Lanaudière (défavorisation matérielle de 7 % à 50 % selon la MRC), région pionnière en intersectorialité (table intersectorielle) · devis en plusieurs phases · O2 : SNA mixte séquentielle explicative, déroulée à partir du CLSC

Quels profils ?

O1 · IDENTIFIER
Revue de portée
4 à 6 vignettes, validées par 6 à 8 acteurs

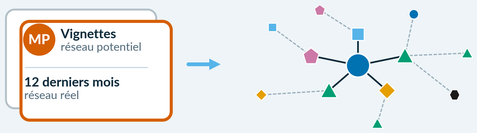
Études publiées → Profils récurrents → Vignettes

→ des profils devenus vignettes

MP *Son profil est repéré dans les études*

Qui mobilise qui ?

O2 · ANALYSER
Cartographie à partir du CLSC
3 CLSC, puis les interlocuteurs qu'ils nomment



→ réseaux potentiels et réels

MP *Elle devient une vignette*

Pourquoi et comment ?

O2 · ANALYSER
SNA qualitative
15–25 entretiens · 2 à 3 parcours réels par profil

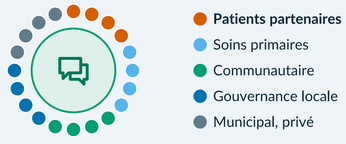


→ explications des interactions

MP *Son parcours réel est expliqué*

Que recommander ?

O3 · RECOMMANDER
Atelier délibératif
15–20 participants, dont des patients partenaires



→ des recommandations par profil

MP *Son dossier est délibéré en atelier*

Intégrer

32 mois · 2026 → 2029
Tableau conjoint par profil

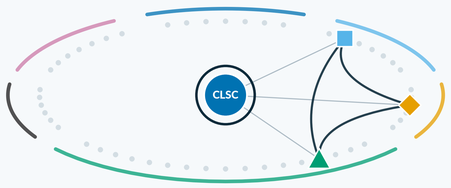
Profil	Réseau	Pourquoi	Reco.
A			
B			
C			

MP *Des repères pour son profil*

03 Résultats anticipés

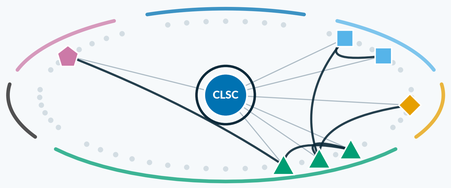
Exemples fictifs · **dans chaque CLSC, le réseau égocentré change selon le profil**

A Dominante logement
avis d'expulsion



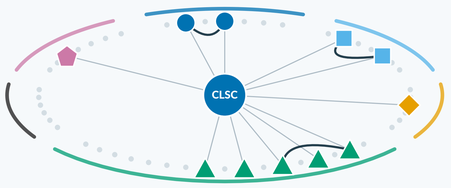
3 partenaires, tous reliés · le CLSC coordonne

B Mme Protocole
logement · alimentation · dettes



7 partenaires, encore reliés · le CLSC coordonne

C Cumul + dépression
mêmes besoins, plus une dépression



11 partenaires, peu reliés · sans coordonnateur

CLSC (ego) · coordonnateur désigné · lien déclaré par les partenaires · organisation non mobilisée
Santé et services sociaux · Première ligne, pharmacies · Communautaire · Municipal · Éducation, petite enfance · Emploi, justice, privé

H1 **Les secteurs changent** selon le profil → *composition par secteur*
H2 **Un noyau commun,** une périphérie propre → *partenaires communs*
H3 **Plus de partenaires,** mais moins reliés → *taille et densité*
H4 **Le CLSC navigue** et coordonne ? → *coordonnateur désigné*
H5 **Le genre change-t-il** la réponse ? → *versions femme, homme*
≠ **Réel ou potentiel :** quel écart ? → *vignettes vs 12 mois*

04 Impacts et retombées

Pas un « réseau idéal » universel : des repères pour chaque profil.

Pour les personnes
Une réponse ajustée à leur combinaison de besoins

Pour le CLSC et ses partenaires
Des repères : qui mobiliser, comment se relier, qui coordonne

Pour la politique de première ligne
Un état de départ ; des recommandations selon les quatre rôles du CLSC

Pour la recherche
Une hypothèse profil–réseau ; l'écart entre réseaux potentiels et réels

potentiel ≠ réel

Diffusion : restitution aux 3 territoires · protocole publié (OSF) · articles

Toutes les versions
FR · EN · ES · 中文 · العربية · Atikamekw · ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐎᓐ · Innu
daltonisme · basse vision · FALC · audio

Vos idées
commentaires · lectures · contacts · idées de méthode

Mon parcours
erjb-web.github.io

Références : CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell et Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017 ; 2026, politique sur les soins et services de première ligne · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016 · Version adaptée au daltonisme : couleurs Okabe-Ito et une forme par secteur